

Pharmacodépendance

Médicaments			
	Epidémiologie	Risques / Intoxication	Prescription / usage non conforme / Antidotes ...
Les psychotropes non opiacés Anxiolytiques, Hypnotiques, ATD, Antipsychotiques, régulateurs de l'humeur, psychostimulants Obtenus le + svnt sur prescrit° mais pas tjr prescrit pr la personne en question Ordo falsifiée (BZD ++)	Psychotropes les + conso en France : anxiolytiques remboursement et consommat° ont ↓ en France MAIS : BZD consommat° élevée, traitement initié par medG dans + de 80% des cas Enjeu de santé pub : 21% des > 15 ans ont déjà été remboursé d'un psychotrope ⚠ conso chez les jeunes : 22% des 17 ans ont déjà conso un psychotrope et 7% psychotrope + alcool. Parents qui proposent ou propre initiative	Ensemble des consommateurs : troubles de la mémoire, du comportement, baisse de la vigilance (accident 🚗), surtout BZD et risques + important en début de ttt et prise avec de l'alcool. En cas d'ATCD médicaux : variabilités du métabolisme, ttt au long cours ... : risque de détresse respi Mésusage : risque d'abus, dépendance, usage récréatif, soumission chimique Accidents de la route : 3,4% des accidents mortels sont liés à un médoc (50% à cause des BZD), risque x8 si prise avec alcool Benzodiazépines : 1er produit psychotrope entraîne dépendance dans 9% des cas	Durée de prescription non respecté : Anxiolytiques max 12 sem, hypnotiques 4 sem La durée médiane d'un ttt au BZD = 7 mois Usagers de drogues : BZD obtenus ++ par prescrit°, limite entre thérapeutQ et défonce floue Médicaments en jeu : oxazépam, clonazépam (mais ↓), alprazolam, bromazépam Usage criminel : BZD et soumission chimique (Zolpidem et Alprazolam)
Les psychotropes opiacés Produit sédatif d'origine naturel (opiacés ou opioïdes) Antalgiques, antitussifs, TSO, anesthésiques Antalgiques opiacés : Douleurs modérées à sévères Dépendance psychique et physique Pallier II (codéine, tramadol) et Pallier III (morphine, fentanyl ..)	France 3ème position pour conso d'antalgiques opiacés faibles (Tramadol +++) Consommation opiacés forts est la + faible en France Après Tramadol, codéine qui est le + utilisé puis opium (association avec paracétamol) Opiodes faibles diminuent en 2011 et stabilisés Opiodes forts : augmentat° depuis 10 ans (Morphine ++)	Intoxication par opiacés : 1) Coma (calme, hypotonique avec myorelaxation) 2) Bradypnée (Fréquence respi <12/min) 3) Myosis (bilatéral, serré, en tête d'épingle) Tous les morphiniques induisent une dépression respi Association avec psychotropes fréquentes : ↑ intensité dép° respi Conso par voie injectable : risques abcès et contaminat° (VIH, VHC, VHB)	Antidotes : Naloxone : antago pur et spécifQ des R aux opioïdes : bloque effets par compétition DC par surdosage : 400/an en France Surdosage : nécessite PEC médicalisé en + de l'antidote Antitussifs opiacés : détournement en Purple Drank, potentiel d'abus et dépendance, adolescents ++. Risques : troubles de la vigilance, comportement, convulsions, DC Liste placée sous ordonnance : Codéine, éthylmorphine, dextrométhorphan, noscapine

Pharmacodépendance

Substances illicites			
Différentes catégories	Les dépresseurs : Ralentissement de certaines fonctions ou sensations El courants : ralentissement fonct° respi + endormissement Forte dépendance psychique et physique Accrochage lent à rapide, surdosage : coma, long terme : troubles neurocomportementaux	Les stimulants : Augmente les sensat° et certaines fonct° organQ comme rythme_♥, sensation d'éveils, suivi d'un contre coup : fatigue, irritabilité Forte dépendance psychique Accrochage très rapide, surdosage danger ++, DC malgré PEC précoce Tbles comportementaux et CV graves	Les hallucinogènes : modifient les perceptions visuelles, auditives et corporelles. Très dépendante du contexte et de la personne. Substances : médicaments ou drogues Dépendance physique faible à modérée Attent° : risque de décompensation psychotique
	Description	Teneur & Prix / population	Risques liés à la consommat°
Cannabis	Plante : Cannabis sativa Effets neuropharmacologiques dus au THC 3 formes : herbe, résine, huile Caractère collectif de la consommat°, plus la concentrat° est importante, plus les effets le sont	10€/g herme, 5-7€/g résine Teneur moyenne en THC a presque triplé (26,5% en moyenne pour la résine et 11% pour l'herbe) Population adolescente : Collégiens : 1ère substance illicite consommé, à partir de la 4ème, mais devient de + en + jeune, garçons ++ Fin de l'adolescence : Près de 4 ado sur 10 ont déjà consommé	Effets neuro psy : apparaissent au bout de 15 à 20 min Prise unique : euphorie modérée, sentiment de bien être puis somnolence, affaiblissement de la mémoire, tbles de l'attention, ↑ du temps de réaction, tables coordination motrice, potentialise les effets de l'alcool, symptômes psy : anxiété, hallucinations Usage régulier : ↓ des capacités de mémorisation et d'apprentissage, désintérêt pour les activités habituelles, fatigue physique et intellectuelle, humeur dépressive Niveau élevée de conso : dépendance, problèmes relationnelles, scolaires, pro Impact de la conso : ↑ accidents de la route, cancers, risques CV (pas que du au THC mais aussi aux produits)
Cocaine Forte dépendance psychiques	Substance d'origine végétale, obtenue par transfo de la feuille de coca Stimulant Conso par voie nasale, inhalat° ou IV Principal produit de coupe : Lévomisole : vermifuge, faible cout, pptés physicochimiques semblables à la coc mais responsable de bcp de complicat°	Jeunes de 17 ans : niveau d'expérimentat° = 2,8% Pris 70-80€/g ↑ de la pureté (60%)	Sensation de puissance intellectuelle et physique : fatigue + sensation d'euphorie Puis phase de descente : dépressif, anxiété, irritabilité Complications : Cardiaque (↑ Pa et vasoconstrict°), neurologiques (AVC, convulsions), infections, troubles délirants
MDMA / amphet	Drogues de synthèse MDMA : hallucinogène à forte dose, avalée, sniffée (+rare) Amphét : Psychostimulant, poudre sniffée, injectée (+rare)	MDMA : 54€/g cristal, 2,5 à 10€ le cp, dose ne cesse d'augmenter, un cp peut être supérieur à la dose toxique Amphet : 15€/g, teneur près de 40% Parmi les jeunes de 17 ans : expériementat° : MDMA 3,4% et 2,3% amphet	Dose considérée comme toxique : 120mg
Héroïne	Opioïde Poudre blanche injectée, sniffée ou fumée Pptés comparables à celle de la morphine mais act° + intense, + rapide, + brève	35-40€/g pureté 15/17% Jeunes : expérimentat° : 0,7%	Dépendance +++, overdose souvent mortelle
Hallucinogènes	Champignons/plantes ou de synthèse (LSD, Kétamine, GHB) Kétamine : anesthésQ, dose modérée : effet euphorisant, dose forte : hallucinations, effets dissociatifs GHB : anesthésQ euphorisante puis sédative et amnésie	Jeunes de 17 ans : expérimentat° : 1,6%	Distorsions des percept° visuelles, auditives, spatiales, temporelles, et de son corps Complications : bads trips, épisodes délirants, effets parfois durables, trauma graves, comas Comas + : kétamine et GHB

Pharmacodépendance

Nouveaux produits de synthèse	Très hétérogènes, imitent les autres substances En France : Cannabinoïdes, phénéthylamines (MDMA), Méthoxétamine (kétamine mais + puissante)	Bcp de ventes sur internet 8 à 20€/g 3,8% d'expérimentat° chez les jeunes de 17 ans (bcp de cannabinoïde)	
Poppers	dérivés du nitrite		Inhalat° : euphorie, rire, vasodilatat°, contexte sexuel Prise unique : nausées, vomissements, céphalées Prise répétées : lésions nasales et du visage, atteintes hépatQ Intoxicat° : hypoT artérielle, tbles CV, exceptionnellement mortel, perte de l'acuité visuelle
Protoxyde d'azote	Gaz détourné de son usage		pptés euphorisantes Inhalat° Risques immédiats : brulures par le froid, céphalées, confusion, chute, tble du rythme, asphyxie, DC Usage régulier : atteintes hématologiques et neurologiques (carences en vitamine B12)